

The background of the slide is a cityscape at night, featuring a prominent skyscraper and a busy highway with light trails from cars. The text is overlaid on a semi-transparent grey shape.

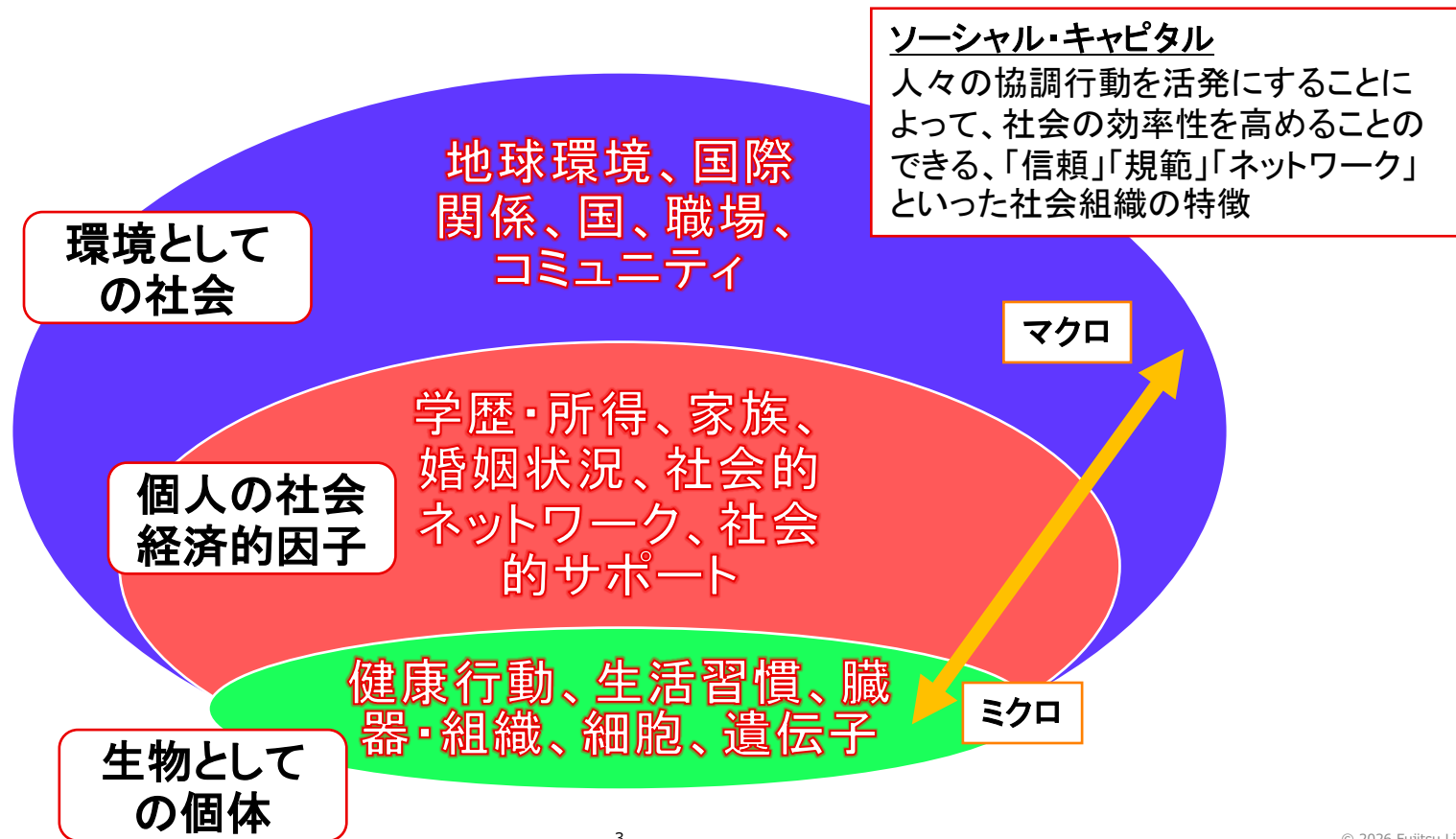
労働現場における 行動変容の実践 -個人と組織へのアプローチ

富士通株式会社
産業保健統括部
佐藤 博貴

健康推進本部
主任産業医

- 「健康と疾病に関する心理社会科学的、行動科学的*および医学生物学的知見と技術を集積統合し、これらの知識と技術を病因の解明と疾病の予防、診断、治療およびリハビリテーションに応用していくことを目的とする学際的学術」（国際行動医学学会憲章、1990）

*「科学的に人間の行動を観察し、行動変容に伴う変化を測定することで、その規則性を見究め、現象を把握するための学問」である行動科学を用いたアプローチ（行動科学的アプローチ）を用いて、**行動変容**を促す。



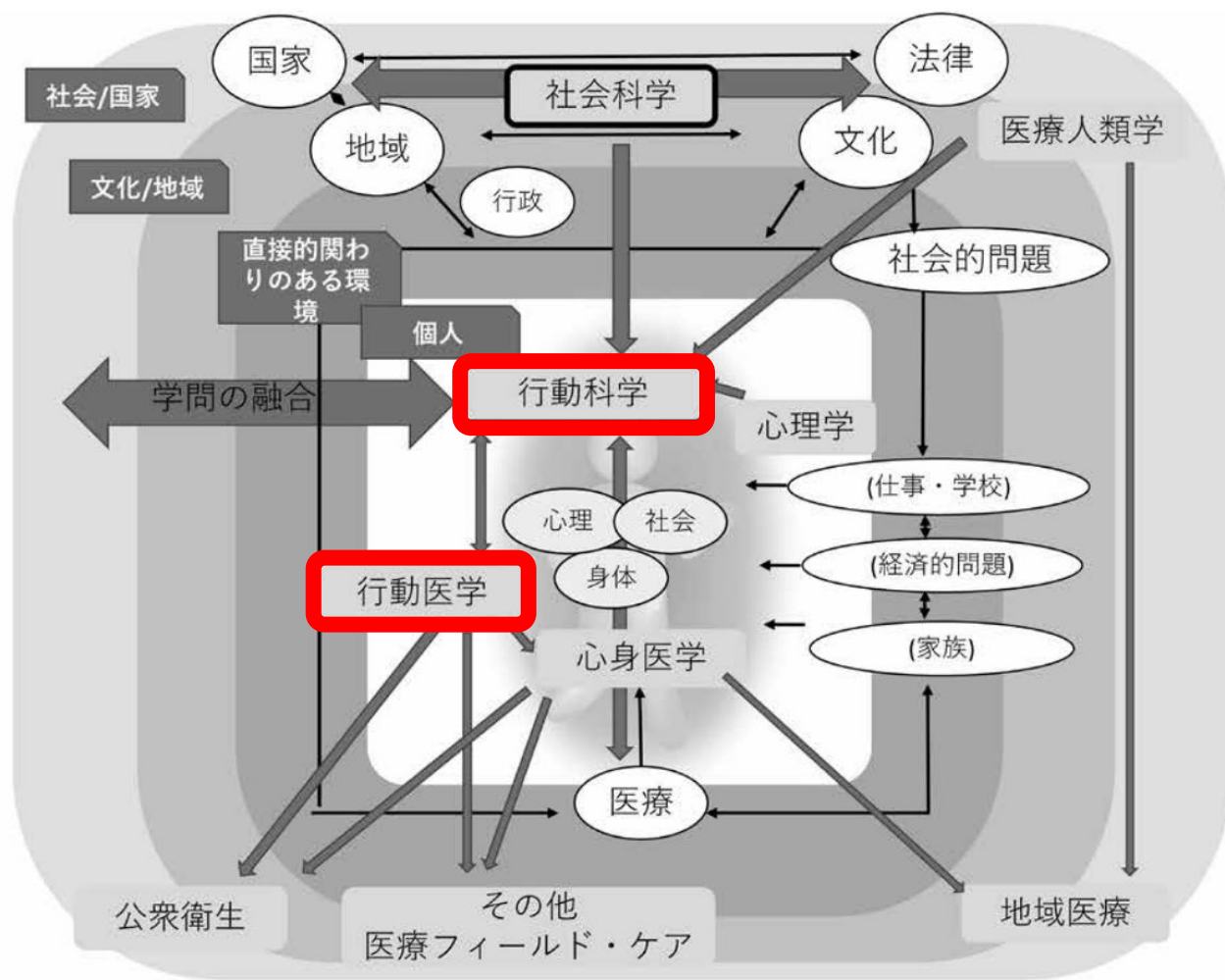
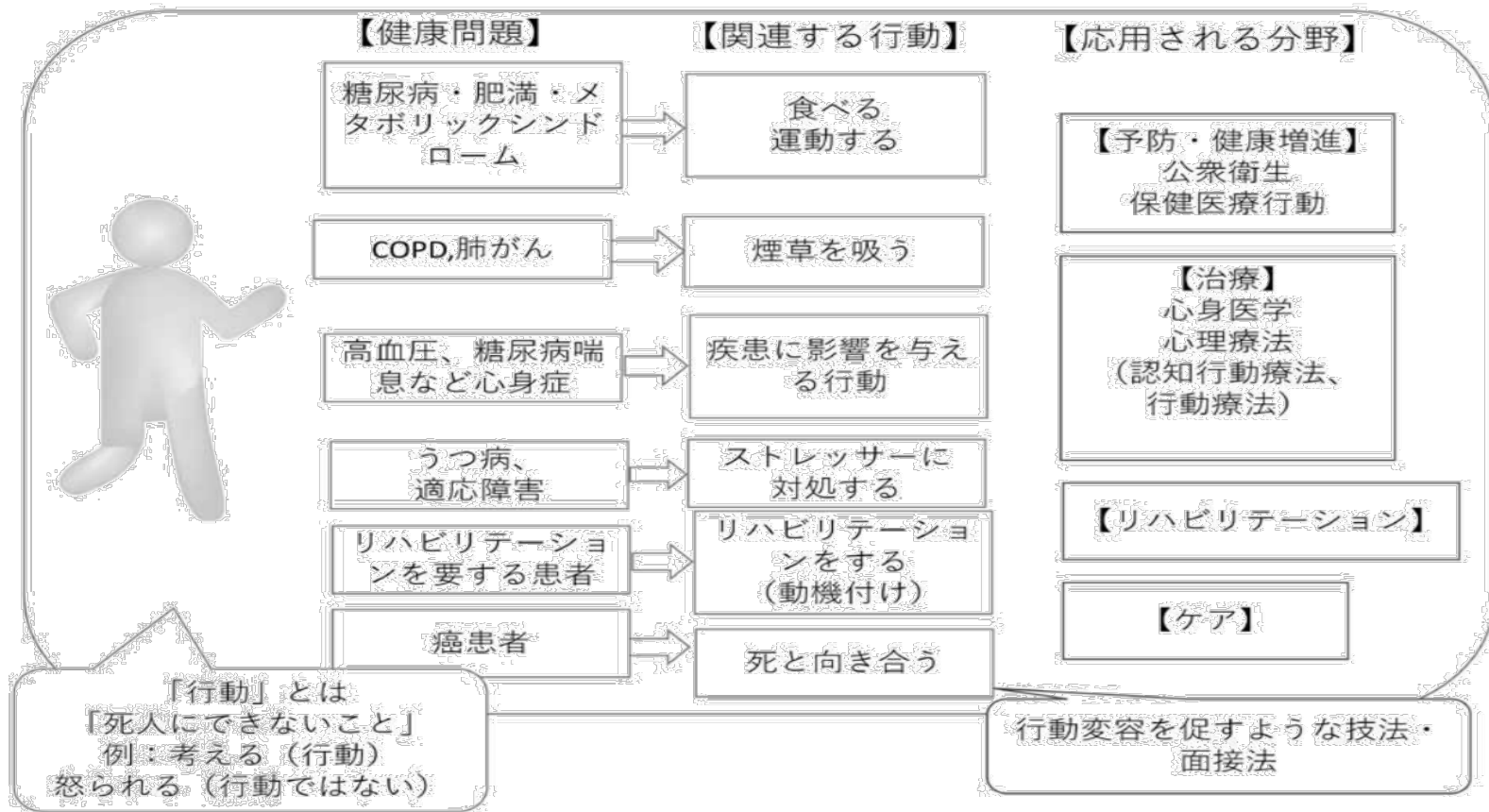


図1 行動科学と医療の関係性



治療

心身症
不安障害
気分障害
問題行動

行動療法
認知行動療法
リラクセーション

行動医学は
私たちの健康と生活に
深く関わっているのです。

疾患の予防
健康行動の確立・維持

疾病予防

疾病管理

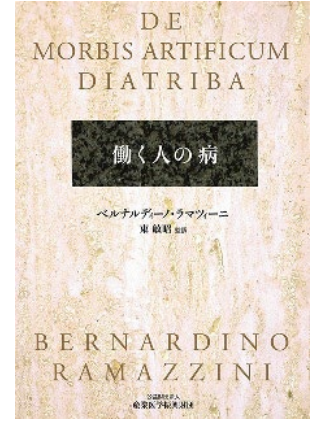
治療における援助

慢性身体疾患
生活習慣病
・糖尿病
・高血圧
・虚血性心疾患
・慢性疼痛など

企業における健康増進活動

- 「働く人々がその仕事に従事するがゆえにかかる病気は、誠に多種多様にわたる。その仕事によって得る代償は、時に彼らの健康にとって致命傷であったりする。それについて、私は次の二つが原因であると考えている。」
- 「第一の、そして最も可能性の高いものとして、彼らが扱う物質の有害性があげられる。人間にとって有害な蒸気を出したり、微細な粒子を放散させたりして、特有の病気を引き起こす。」
- 「第二の原因に私があげるのは、激しく、そして不規則な動作や、不自然な姿勢が身体に及ぼす影響である。それが原因で、生命の維持に必要な器官のあるべき構造が損なわれ、重大な病気が次第々々に進行することになる。」

(出典：ベルナルディーノ・ラマツィーニ著、東敏明監訳；「働く人の病」(1713))



ベルナルディーノ・ラマツィーニの像
産業医学振興財団HPより引用

職業病・作業関連疾患の概念

- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修（※）であって厚生労働大臣が指定する者（法人に限る。）が行うものを修了した者
（※）現在、①日本医師会の産業医学基礎研修、②産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。
- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者（現在、定められている者はありません。）

労働安全衛生規則第14条第2項

2010年の産医大調査によると需要は2000-2500社、実際に専属産業医として働いている医師は1700名程度と推定

厚生労働省「産業保健のあり方に関する検討会」第2回（令和4年11月14日）資料 より抜粋

産業医の活動形態 ※1

嘱託産業医 71%

専属産業医 5%

兼業産業医 25%

勤務先の産業医（診療・管理等の他業務も兼任）

「日本医師会認定産業医」制度

令和4年（2022年）12月31日
時点で医師数343,275人

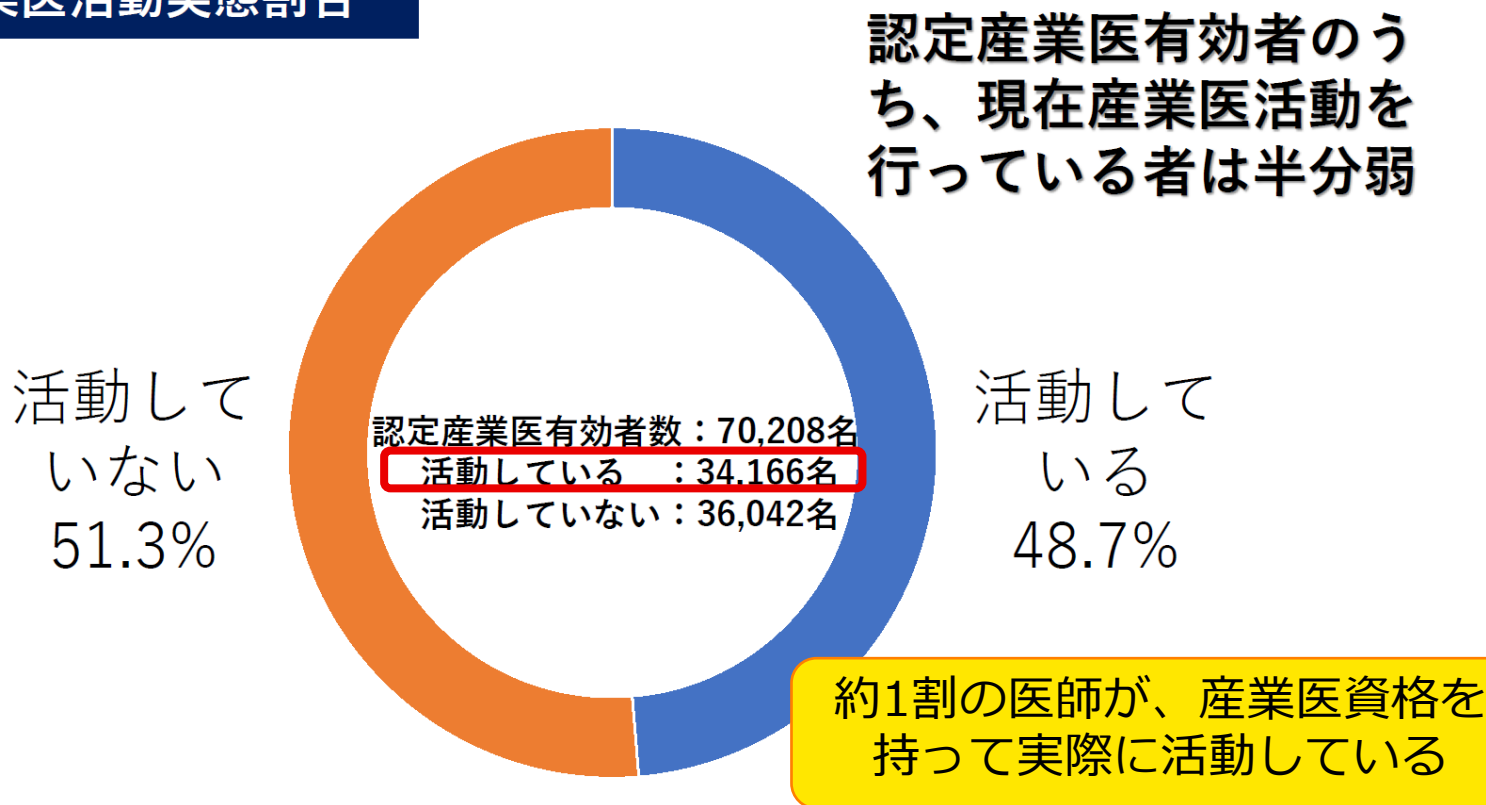
- 平成2年発足。総数 107,315人（有効人数 70,208人） ※2
- 基礎研修 50単位以上（産業医活動を行うために必要な基本的知識・技術を修得）を終了した場合申請可能

本業の傍ら、各事業場に応じた内容で、
産業医活動をする者が殆どである。

※1：産業医活動に対するアンケート調査（H27年 日本医師会）日本医師会認定産業医の中から無作為で抽出した1万人（複数回答）

※2：R4.10.27現在。有効人数とは 総数から死亡者、辞退者および有効期限切の者を除いた人数。

産業医活動実態割合



産業医の選任義務（安衛則第13条第1項）

	1～49人	50～999人	1000～3000人	3001人以上
産業医の選任義務の別	選任義務なし (医師等による健康管理等の努力義務)	産業医 (嘱託可※)	産業医 (専属)	2人以上の産業医 (専属)

※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。

産業医の職務（安衛則第14条第1項）

次の事項で、医学に関する専門的知識を必要とするもの

- ① 健康診断・その結果に基づく措置
- ② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
- ③ ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
- ④ 作業環境の維持管理
- ⑤ 作業管理
- ⑥ 上記以外の労働者の健康管理
- ⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
- ⑧ 衛生教育
- ⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止

- …具体的措置を、産業医以外の他の医師に委ねることができるもの

産業医の権能

- ◇ 事業者、総括安全衛生管理者への勧告
(安衛法第13条第3項、安衛則第14条第3項)
- ◇ 衛生委員会における労働者の健康障害防止対策等の調査審議
(安衛法第18条)
- ◇ 衛生管理者への指導、助言
(安衛則第14条第3項)
- ◇ 労働者の健康障害防止のための職場巡視及び現場における緊急的措置の実施
(安衛則第15条)

《平成29年6月施行》

- ◇ 長時間労働者等に関する情報の把握
(安衛則第51条の2、第52条の2等)

作業環境管理

- 有害な物質や危険な機械による健康障害を受けないように作業環境を把握し、曝露対策や安全対策を行う。

作業管理

- 有害要因に曝露しないような作業姿勢や作業手順などを定め、適切に運用されるように管理する。

健康管理

- 働く人自身の健康状態を確認し、必要な治療や健康増進施策などを行う。

	臨床医	産業医
法令	医師法	労働安全衛生法
活動場所	病院・クリニック	企業（事業場としての医療機関含む）
対象	患者	事業主、従業員
職務	患者の治療	労働者の作業環境管理（職場環境の安全） 労働者の作業管理（仕事の量や質、作業方法など） 労働者の健康管理（フィジカル&メンタル）
立場	患者との診療契約	事業主と労働者からの中立・独立的立場
事業主への勧告権	なし	あり

一般健康診断

雇入時の健康診断
(安衛則第43条)

定期健康診断
(安衛則第44条)

特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)

海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)

給食従事者の検便
(安衛則第47条)

自発的健康診断
(安衛法第66条の2)

これらの他にも、指導勧奨
の特殊健康診断がある。

特殊健康診断

じん肺健康診断
(じん肺法第3条)

高気圧業務健康診断
(高圧則第38条)

電離放射線健康診断
(電離則第56条)

特定化学物質健康診断
(特化則第39条第1項)

石綿健康診断
(石綿則第40条第1項)

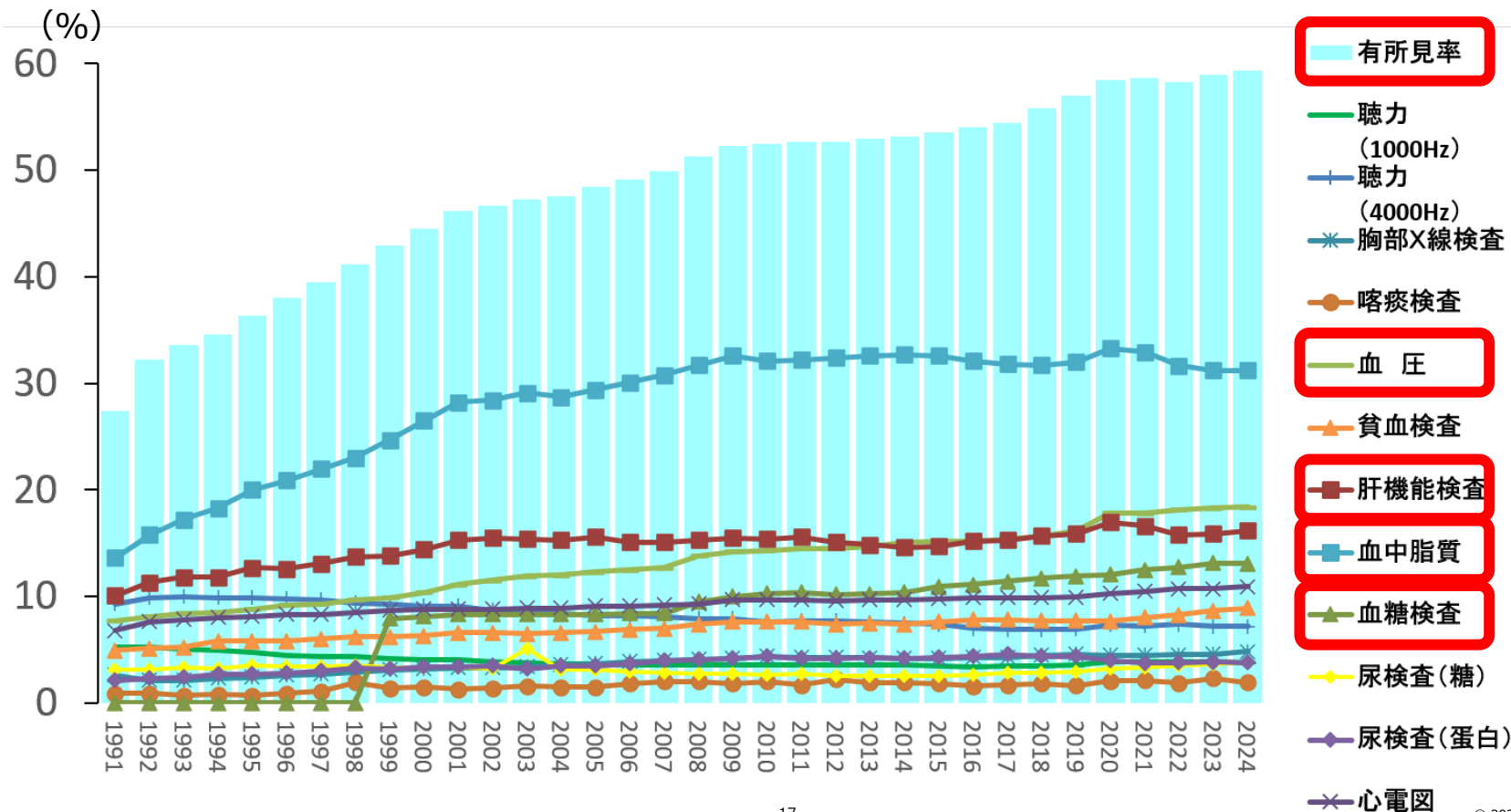
鉛健康診断
(鉛則第53条)

四アルキル鉛健康診断
(四アルキル則第22条)

有機溶剤健康診断
(有機則第29条)

- 事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、労働者の健康管理を適切に講ずる（一次健診、二次健診）。
- 必要に応じて、労働者の実情を考慮しつつ、「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置（就業措置）を講ずる他、作業環境測定の実施、施設や設備の整備、安全衛生委員会への報告など」を行う。
- 個人情報保護、不利益取り扱いの禁止が定められている。

定期健康診断 有所見率の年次推移



就業区分		就業上の措置の内容
区分	内容	
通常勤務	通常の勤務でよいもの	
就業制限	勤務に制限を加える必要のあるもの	勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
要休業	勤務を休む必要のあるもの	療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

※ 実際の措置を行う上では、労働者・事業者双方の話し合いが重要

健康診断結果に基づいた保健指導や早期治療導入による健康状態の改善。

健康状態に合わせた業務内容の調整。

健康教育や健康増進活動などの実施。

□胃がん検診

- 問診、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査
- 50歳以上男女、年2回（毎年実施してもよい）

□子宮頸がん検診

- 問診、視診、子宮頸部細胞診および内診（必要に応じコルポスコピー）
- 20歳以上の女性、年2回

□肺がん検診

- 問診、胸部エックス線検査および喀痰細胞診（50歳以上でブリンクマン指数600以上の者、過去喫煙者含む）
- 40歳以上男女、年1回

□乳がん検診

- 問診、マンモグラフィー（視触診のみは×）
- 40歳以上の女性、年2回

□大腸がん検診

- 問診、便潜血検査
- 40歳以上男女、年1回

これらの項目は、労働安全衛生法で定められた法定項目ではない

⇒個人情報保護法における要配慮個人情報としてどのように取り扱うか課題

労働安全衛生法より引用

（健康教育等）

- 第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
- 2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

（健康の保持増進のための指針の公表等）

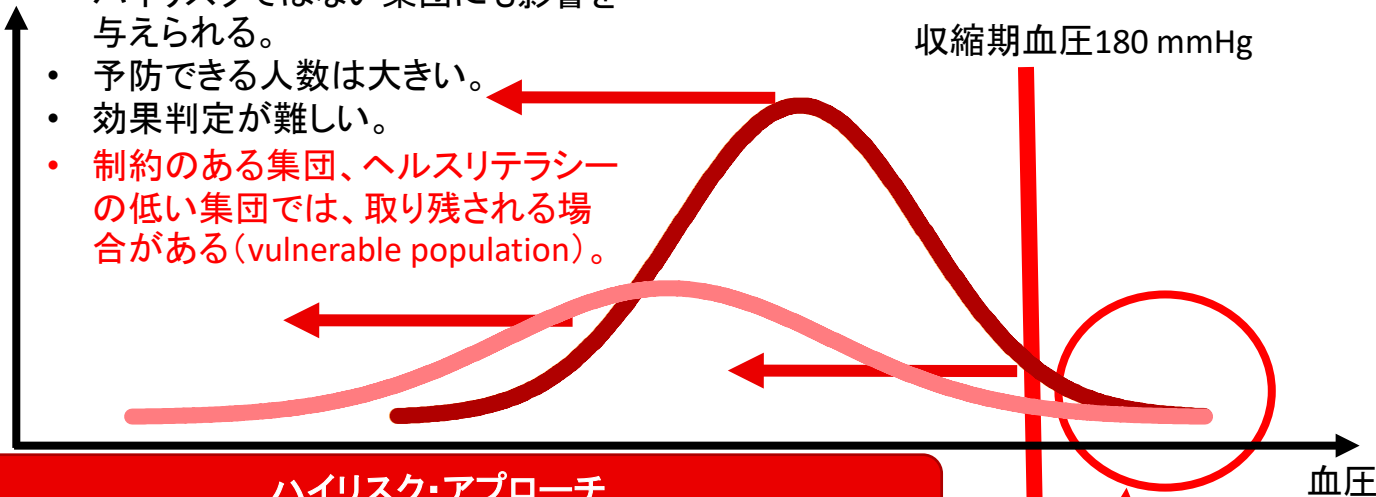
- 第七十条の二 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

1. 事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和63 年健康保持増進のための指針公示第 1 号）
トータル・ヘルスプロモーション（THP）
2. 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（平成 8 年健康診断結果措置指針公示第 1 号）
事後措置、適正配置、労働者への結果通知
3. 労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成18 年健康保持増進のための指針公示第 3 号）
メンタルヘルス
4. 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針（平成27 年心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第 1 号）
ストレスチェック

ポピュレーション・アプローチ 集団全体の健康水準を変化(集団教育、環境整備)

- ・ ハイリスクではない集団にも影響を与えられる。
- ・ 予防できる人数は大きい。
- ・ 効果判定が難しい。
- ・ 制約のある集団、ヘルスリテラシーの低い集団では、取り残される場合がある(vulnerable population)。

人数

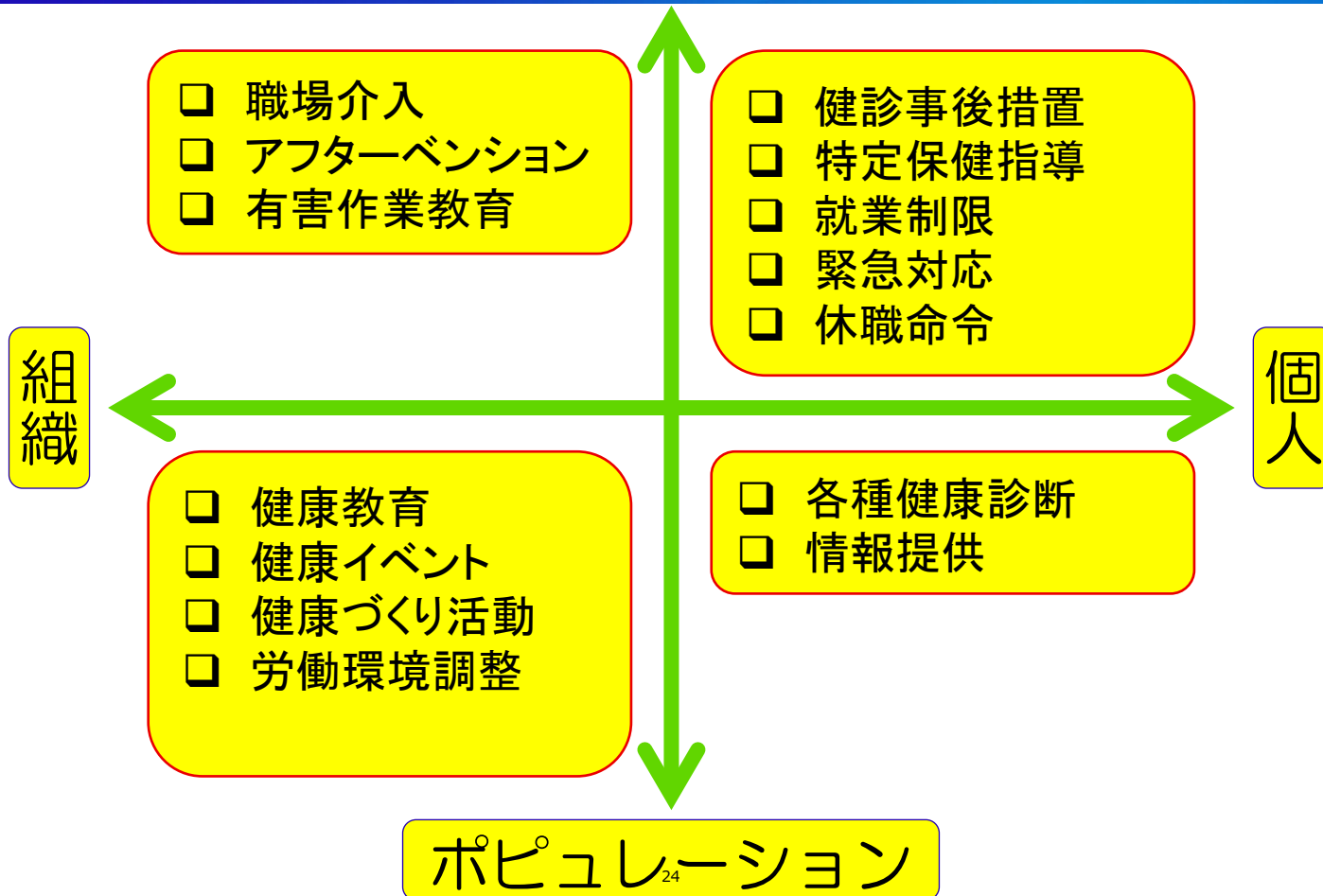


ハイリスク・アプローチ 脳卒中予防のため、重症高血圧群のみ介入(治療、保健指導)

- ・ 緊急的な対応としては不可欠
- ・ 重症高血圧でなければよい？(軽症でも3倍、中等症でも6倍強の発症リスク)
- ・ 予防できる人数のインパクトは？

脳卒中の発症リスク: 7倍以上
(至適血圧群との比較)

ハイリスク

ポピュレーション₂₄

- 職域においては、定期健康診断などの一般健康診断の事後措置に基づく保健指導や、特定健診実施後の特定保健指導がある。また、健康相談として従業員から依頼されることもある。睡眠衛生指導やメンタル相談も含まれる。
- 特定保健指導の実施主体は、各健康保険組合。平成20年4月より開始された特定健康診査（特定健診）の結果に基づき、実施される。対象者は40歳～74歳。実施率の低い団体には、ペナルティあり（後期高齢者支援金の加算）。

特定保健指導の対象者(階層化)

腹囲	追加リスク	④喫煙歴	対象	
	①血糖 ②脂質 ③血圧		40-64 歳	65-74 歳
$\geq 85\text{cm}$ (男性) $\geq 90\text{cm}$ (女性)	2 つ以上該当		積極的 支援	動機付け 支援
	1 つ該当	あり なし		
上 記 以 外 で BMI ≥ 25	3 つ該当		積極的 支援	動機付け 支援
	2 つ該当	あり なし		
	1 つ該当			

(注)喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係ないことを意味する。

- 空腹時血糖100 mg/dl 以上、またはHbA1c (NGSP) 5.6% 以上
- 中性脂肪150 mg/dl 以上、またはHDL 40 mg/dl 未満
- 収縮期血圧 130 mmHg 以上、または拡張期血圧 85 mmHg 以上

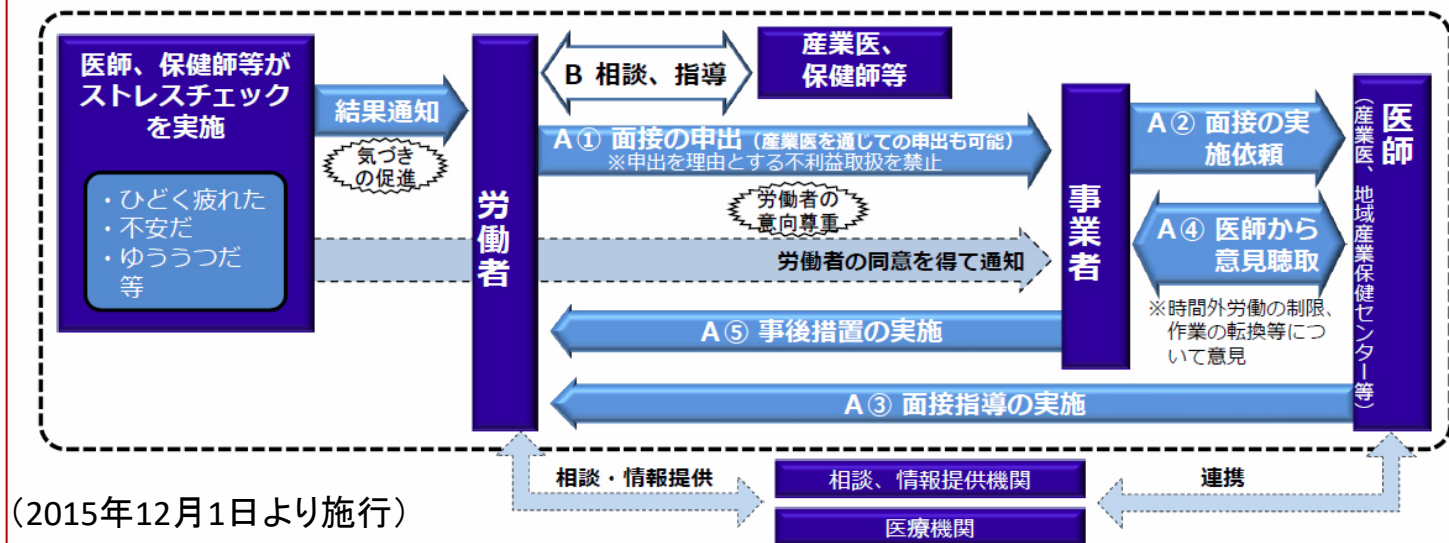
- ストレスチェックの集団分析結果活用
 - ▶ 経営層、職場上司へのフィードバック
- メンタルヘルス教育（セルフケア、ラインケア）
- 健康教育、有害作業教育
- 作業環境改善（有害物質管理、衛生設備設置）
- 照明、温湿度、騒音環境の改善
- 労働時間の管理、ワークライフバランス
- 種々の相談窓口設置
- 管理規定の策定、運用

職場単位から会社全体の施策まで、集団に介入するアプローチは様々ある。

○精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど増加（21年度:234→22年度:308→23年度:325→24年度:475）

- ➡
- 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査（ストレスチェック）の実施を事業者に義務づける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。
 - ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
 - 国は、ストレスチェックを行う医師、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるものとする。

【ストレスチェック制度の概要】



個人への対応：高リスク者

- 健康相談、産業医面談を実施
- 必要に応じ、受診勧奨・職場介入

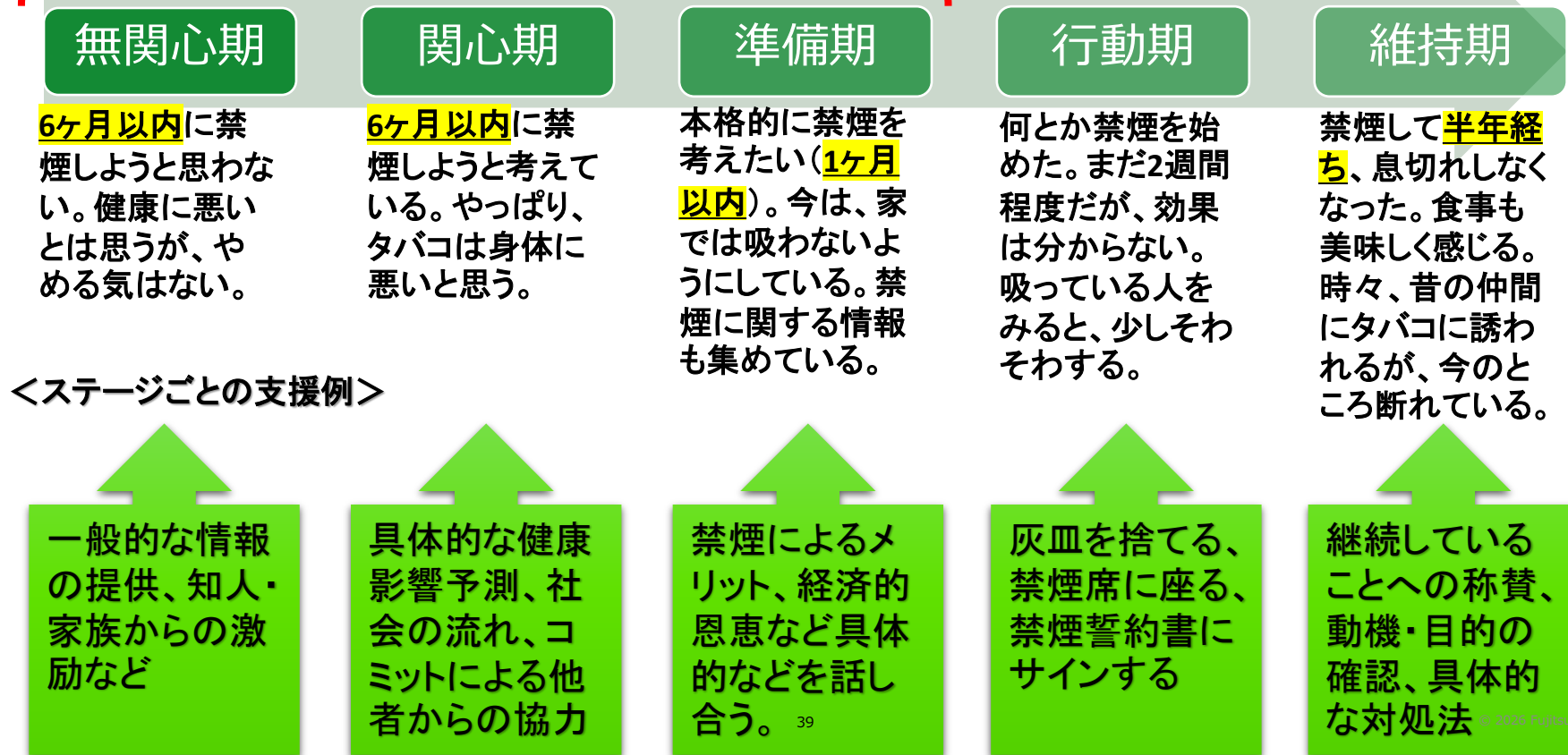
組織への対応：総合健康リスク

- 高リスク職場に対し、職場責任者へフィードバック実施
- 健診受診率などと合わせて共有、職場の課題を探る

行動変容ステージモデル

これらの段階は初期ステージと呼ばれ、恩恵より損失を強く感じている。
→将来の恩恵に注目させ、「できる」という感覚 (self-efficacy; 自己効力感) を持たせる。

Ex. 禁煙



- 37歳、男性。システムエンジニア。
- 身長 168cm、体重 80kg、BMI 28.3
- 健診にて、空腹時血糖値 135mg/dl、HbA1c 6.8%
- 血圧 135/86 mmHg、脂質および肝機能の項目は基準範囲内。胸部Xp、ECGには病的所見なし。
- 製品の開発および納品時期は繁忙。普段の残業は月30時間くらいだが、繁忙期は70時間を超えるときもある。睡眠時間は6時間ほど。
- 妻と子2人の4人暮らし。

- 糖尿病と言われたが、自覚症状は全くない。減量すれば改善すると言われ、少し安心している。知り合いが目を悪くしたり、透析を受けたりしているので心配だった。
- 肥満については前から気になっており、ダイエットに何度か取り組むがなかなか続かない。お米も好きだし、脂物も多い。空腹感に耐えられないこともあり難しいが、またチャレンジしたい。
- お酒も以前は週末飲む程度だったが、最近は仕事のストレスなのか、平日も飲むようになってしまった。酎ハイ350 mlを2本くらい。
- 睡眠は、それなりにとれていると思うが、翌朝の仕事が気になって少し寝つきの悪い日がある。
- 家族からも頑張って痩せるように言われている。まだ子供も小さいので、頑張って健康にならなければと考えている。

- 行動変容ステージは？
- 食事療法の効果についてはどう考えているか？
- 改善の自信はどの程度か？
- 今の状態が続くことの危機感は？
- 改善行動を起こすうえでのハードルは？
- ストレスの対処法は？
- 周囲のサポート状況は？
- 健康は自分の努力によると感じているか？

事例

- 37歳男性、システムエンジニア。BMI 28.3
- 空腹時血糖135mg/dL、HbA1c 6.8%
- 繁忙期は残業70時間超。睡眠は約6時間
- 食事量が多く、飲酒も増加。減量は何度か失敗
- 「またチャレンジしたい。家族からも痩せるよう言われている」

各自で考える問い

1

ステージ

関心期か準備期か。根拠となる発言は何か。

2

障壁

空腹感、食嗜好、ストレス、勤務状況をどう整理するか。

3

支援

自己効力感を下げず、小さな成功体験をどう設計するか。

成果物：初回面談で確認したい質問を3つ、支援方針を1つ作成

対象者の発言を「変わりたい理由」「変わらない理由」「職場要因」に分け、介入点を見つける。

観点	記入する内容	発表時のポイント
行動変容ステージ	無関心期／関心期／準備期／実行期／維持期	判断の根拠を本人の言葉で示す
促進要因	家族の支援、健康になりたい理由、成功体験	強みとして活用できるか
阻害要因	空腹感、食嗜好、飲酒、残業、ストレス	個人の努力だけにしない
初回目標	1～2週間で達成できる小さな行動	測定可能で本人が選べる目標にする

役割

1 産業医

一方的な指導ではなく、本人の価値観・生活背景・不安を引き出す。

2 従業員

改善したい気持ちはあるが、自信が低く、仕事のストレスで飲酒が増えている。

3 観察者

良かった質問、指導的になりすぎた場面、次に深掘りすべき点を記録する。

観察チェック

- 医学的リスクを「脅し」ではなく理解支援として伝えたか
- 本人の成功可能性を高める言葉かけがあったか
- 短期目標が具体的・測定可能・本人選択になっているか
- 職場環境やストレス要因にも触れたか

**進行：面談5分 → 観察者フィードバック
3分 → 役割交代**

状況

- 部署単位の集団分析で高ストレス傾向が悪化
- 長時間労働、上司とのコミュニケーション不足
- テレワーク下で孤立感が強い
- 個人の不調者対応だけでは再発予防が難しい

検討課題

1

個人対応

面接指導、相談窓口、受診勧奨、就業上の配慮を整理する。

2

組織対応

業務量、会議設計、上司支援、チーム内コミュニケーションを見直す。

3

伝え方

個人が特定されない形で、管理職に改善の方向性を共有する。

成果物：職場環境改善策を3つ、管理職へのフィードバック方針を1つ作成

- 行動科学的アプローチは、健康管理だけではなく、職場の作業環境管理、働き方などの作業管理にも有用な考え方である。
- 行動医学としての対応は、①治療そのもの、②疾病管理、③疾病予防の意味合いを持つ。
- 企業においては、個人アプローチと組織アプローチを組み合わせることによって、従業員の健康増進及び組織の活性化を目指し、生産性向上に寄与できる。

Thank you

